

Konsekwencje *somatyczne*

Bulimia ma poważne skutki fizyczne — często niedoceniane, bo BMI bywa w normie. Sześć obszarów: elektrolity, zęby, przełyk, układ pokarmowy, serce, hormony. Ocena lekarska konieczna.

CZAS: 15 min · psychoedukacja Przed planowaniem leczenia · z lekarzem

ŹRÓDŁO: Mehler & Andersen (2017); Mitchell i in. (2016); NICE (2017)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **sześć obszarów konsekwencji** somatycznych (sekcja 1), zobacz, **kiedy konsultacja lekarska jest pilna** (sekcja 2). Sekcja 3 — Twój plan oceny medycznej. Sekcja 4 — notatki dla lekarza.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Bulimia ma **poważne** konsekwencje somatyczne, ale są one często niedoceniane przez pacjentów i klinicystów, ponieważ BMI bywa w normie. To *pułapka*: „*wyglądam dobrze, więc nie ma problemu*”. Mehler & Andersen (2017): bulimia powoduje multisystemowe uszkodzenia, z których część jest **zagrożająca życiu** (arytmie sercowe z hipokaliemii). Mitchell i in. (2016): śmiertelność standaryzowana w bulimii wynosi **1,93** — to znaczy prawie 2× wyższe ryzyko zgonu. NICE (2017): każdy pacjent z BN powinien mieć **ocenę lekarską** na początku leczenia: morfologia, elektrolity, EKG, ocena stomatologiczna. Część konsekwencji jest **odwracalna** przy zaprzestaniu kompensacji; część **trwała** (erozja zębów). Zrozumienie konsekwencji ma **uświadomić**, że to nie jest „*nieszkodliwy nawyk*”.

01 = Sześć obszarów konsekwencji

1 · ELEKTROLITY

Hipokaliemia (40-50% wymiotujących), hiponatremia, zasadowica. Ryzyko arytmii. Kontrola: morfologia + jonogram.

2 · ZĘBY

Erozja szkliwa — 62% pacjentów (Hermont 2013). Próchnica, nadwrażliwość. Często pierwsza wskazówka diagnostyczna. Stomatolog ED-świadomy.

3 · PRZEŁYK I ŚLINIANKI

Esofagitis, refluks. Powiększenie ślinianek (25-50%) — „*twarz chomika*”. Ryzyko zespołu Mallory-Weiss (krwawienie z przełyku, pilne SOR).

4 · UKŁAD POKARMOWY

Zaparcia (środki przeczyszczające), „*cathartic colon*” (trwałe uszkodzenie jelita), refluks. Częste wzdęcia, ból brzucha.

5 · SERCE

Wydłużenie QTc, ryzyko arytmii (z hipokaliemii). Kardiomiopatia przy nadużywaniu ipekaku. EKG przed leczeniem.

6 · HORMONY

Nieregularne miesiączki (40-50%), subkliniczna niepłodność. Zaburzenia osi tarczycy/nadnercza. Konsultacja endokrynologa przy planowaniu ciąży.

02 ✗ Kiedy konsultacja lekarska jest pilna

NATYCHMIAST — SOR

- Krew w wymiotach lub stolcu
- Bóle w klatce piersiowej, kołatanie serca
- Skurcze mięśni, drętwienia
- Omdlenia, zawroty głowy
- Silne osłabienie

PLANOWO — POZ LUB SPECJALISTA

- Erozja zębów, nadwrażliwość
- Nieregularne miesiączki
- Powiększenie ślinianek
- Przewlekłe wzdęcia, ból brzucha
- Chroniczne zmęczenie

03 Plan oceny medycznej — NICE (2017)

Każdy pacjent z bulimią powinien mieć **bazową ocenę** przed rozpoczęciem leczenia, a potem regularne kontrole. To nie inwazyjne badania — standardowy panel + konsultacje. Klinicysta i lekarz pracują w zespole.

BAZOWA OCENA

- Morfologia krwi + jonogram (Na, K, Cl)
- Glukoza, mocznik, kreatynina
- Próby wątrobowe (AST, ALT)
- TSH, FT4
- EKG (12 odprowadzeń)
- Konsultacja stomatologiczna
- Ocena masy ciała (bez fokus klinicznego)

KONTROLE REGULARNE

- Jonogram + EKG co 1–3 mies. przy utrzymujących się objawach
- Stomatolog co 6 mies.
- Ginekolog (kobiety) przy zaburzeniach miesiączkowania
- Endokrynolog przy planowaniu ciąży
- Konsultacja psychiatryczna przy współwystępujących objawach

04 Notatki dla lekarza — co warto powiedzieć

Wstyd często prowadzi do ukrywania pełnego obrazu objawów. To pułapka — lekarz **potrzebuje** pełnej informacji, by ocenić ryzyko i zaplanować właściwą diagnostykę. Twoja otwartość chroni Twoje zdrowie.

MOJE ZACHOWANIA KOMPENSACYJNE

— *jakie, jak często; bez ocen, tylko fakty*

OBJAWY FIZYCZNE, KTÓRE ZAUWAŻAM

— *zęby, miesiączki, zmęczenie, kołatanie, ból brzucha*

Klucz: bulimia *nie* jest „niewidoczna” tylko dlatego, że BMI bywa w normie. Multisystemowe konsekwencje są realne i część z nich **zagroza życiu** (arytmie sercowe). Mitchell i in. (2016): zwiększone ryzyko zgonu jest *nie* przede wszystkim z głodzenia (jak w anoreksji), lecz z **zaburzeń elektrolitowych i samobójstw**. Dobra wiadomość: *większość* konsekwencji somatycznych bulimii jest **odwracalna** — elektrolity, EKG, ślinianki, miesiączki — wszystkie wracają do normy w ciągu tygodni-miesięcy po zaprzestaniu wymiotów i regularnym jedzeniu. Trwałe są tylko niektóre: *erozja zębów* i *cathartic colon*. To kolejny argument za wczesną interwencją. Konsultacja lekarska *nie* jest oceną moralną — lekarz nie ocenia, lekarz *chroni* Twoje zdrowie. Bądź otwarty/-a, daj specjalistce narzędzia do realnego pomagania.